Клинические рекомендации

Круп, эпиглоттит, постинтубационный отёк гортани

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**J05.0** — Острый обструктивный ларингит [круп] **J05.1** — Острый эпиглоттит **J38.4** — Отек гортани **J38.6** — Стеноз гортани
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 14.01.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Союз педиатров России; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов; Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/352_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Этиология 4

2.3 Степени стеноза гортани 4

2.4 Клиническая картина 5

3. Диагностика 6

3.1 Осмотр и аускультация 6

3.2 Пульсоксиметрия 6

3.3 Общий анализ крови и С-реактивный белок 6

3.4 Посев с надгортанника и посев крови 6

3.5 Рентгенография мягких тканей шеи 7

3.6 УЗИ гортани и фиброларингоскопия перед экстубацией 7

3.7 Дифференциальная диагностика 7

4. Лечение 9

4.1 Круп 9

4.2 Эпиглоттит 10

4.3 Постэкстубационный отёк гортани 11

4.4 Стеноз гортани вследствие отёка и хирургическое лечение 12

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 13

5.1 Показания к госпитализации 13

5.2 Профилактика 13

6. Источник и актуальность 14

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 14

1. Основные положения

- Круп (острый обструктивный ларингит): воспаление гортани и подскладочного пространства с сужением просвета, как правило вирусной природы; болеют преимущественно дети **от 6 месяцев до 6 лет**. Эпиглоттит: острое бактериальное воспаление надгортанника (Haemophilus influenzae типа b), может быстро привести к асфиксии.
- Лечение крупа:
  1. всем пациентам: кортикостероиды (#дексаметазон однократно или будесонид ингаляционно);
  2. антибиотики и паровые ингаляции не рекомендуются;
  3. тяжёлый круп: ингаляция #эпинефрина;
  4. сатурация **92% и ниже**: оксигенотерапия;
  5. стеноз IV степени: интубация трахеи.
- Эпиглоттит:
  1. экстренная госпитализация в отделение с возможностью интубации;
  2. положение только сидя;
  3. ранняя интубация трахеи;
  4. антибиотик внутривенно всем пациентам;
  5. ротоглотку осматривают только в операционной в готовности к интубации;
  6. ингаляции, седативные средства и беспокойство ребёнка противопоказаны.
- Постэкстубационный отёк гортани:
  1. системные глюкокортикоиды внутривенно **не менее 48 часов**;
  2. нет улучшения **в течение часа**: реинтубация без прерывания лечения.
- Госпитализация при крупе:
  1. стеноз гортани II–III степени;
  2. невозможность адекватного лечения дома;
  3. прогрессирующее ухудшение.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

1. острый обструктивный ларингит (круп): воспаление гортани и тканей подскладочного пространства с сужением просвета гортани; прежние названия — «стенозирующий ларинготрахеит», «ложный круп»;
2. эпиглоттит: остро возникшее бактериальное воспаление надгортанника и окружающих тканей, может быстро привести к жизнеугрожающему нарушению проходимости дыхательных путей.

2.2 Этиология

Круп: наиболее частые возбудители — респираторные вирусы, причём до 80% случаев обусловлено вирусом парагриппа. Среди прочих возбудителей встречаются вирусы гриппа A и B, аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус, риновирусы и другие. В крайне редких случаях причиной бывают бактерии, например Mycoplasma pneumoniae.

Постинтубационный отёк гортани: причиной является эндотрахеальная интубация, при которой нередко возникает поражение гортани от давления эндотрахеальной трубки. Оно проявляется отёком разной степени, изъязвлениями, грануляциями и ограничением подвижности голосовых складок, что приводит к сужению просвета в первые 24 часа после экстубации. У половины пациентов отёк требует реинтубации.

Эпиглоттит

В подавляющем большинстве случаев возбудителем является Haemophilus influenzae типа b (более 90%). В странах с массовой иммунизацией против гемофильной инфекции у вакцинированных детей эпиглоттит встречается редко и может быть вызван другими возбудителями, а эпиглоттит, обусловленный этим возбудителем, чаще встречается у взрослых. В редких случаях его вызывают пневмококк, стрептококки групп A и C, золотистый стафилококк, Moraxella catarrhalis и другие.

2.3 Степени стеноза гортани

Степени стеноза гортани по В. Ф. Ундрицу (1969)

Степень	Клинические проявления
I (стадия компенсации)	Осиплость, грубый навязчивый кашель, умеренная одышка
II (стадия неполной компенсации)	Осиплость, грубый навязчивый кашель, выраженная одышка, возбуждение, дыхание с участием вспомогательной мускулатуры, втяжение податливых мест грудной клетки, раздувание крыльев носа, цианоз носогубного треугольника, тахикардия
III (стадия декомпенсации)	Осиплость, грубый навязчивый кашель, беспокойство, страх, возможна апатия, резкая одышка с выраженным втяжением податливых мест грудной клетки, бледность, акроцианоз
IV (терминальная стадия, асфиксия)	Сознание отсутствует, резкая бледность и цианоз, гипотермия, возможны судороги, мидриаз, частое поверхностное дыхание, артериальная гипотензия, нитевидный пульс; предшествует остановке дыхания и сердца

Шкала тяжести крупа Westley

Признак	Баллы
Стридор	отсутствует: 0 при возбуждении: 1 в покое: 2
Втяжение уступчивых мест грудной клетки	отсутствует: 0 лёгкое: 1 умеренно выраженное: 2 резко выраженное: 3
Проходимость дыхательных путей	нормальная: 0 нарушена умеренно: 1 значительно снижена: 2
Цианоз	отсутствует: 0 при двигательной активности: 4 в покое: 5

Признак	Баллы
Сознание	без изменений: 0 нарушения сознания: 5

Оценка суммы баллов

1. лёгкий круп: **2 и менее**;
2. среднетяжёлый: **3–7**;
3. тяжёлый: **8 и более**;
4. угроза остановки дыхания: **12 и более**.

За рубежом используют также классификацию по степени тяжести: лёгкий, среднетяжёлый, тяжёлый и терминальный круп по лающему кашлю, стридору, втяжению межрёберий, возбуждению или сонливости и цианозу.

2.4 Клиническая картина

Круп

Начало

1. признаки ОРВИ: ринорея, першение в горле, кашель;
2. чаще невысокая температура;
3. перед развитием стеноза возникают осиплость и (или) сухой грубый кашель, затем лающий кашель и шумный вдох (стридор);
4. симптомы, как правило, появляются вечером, ночью или под утро.

При стенозе I степени стридор в покое отсутствует и возникает при беспокойстве или нагрузке; при II степени стридор слышен и в покое. Стеноз III степени требует экстренной помощи.

Более 2/3 обращаются со стенозом I степени, тяжёлый стеноз — менее чем у 1% детей; симптомы обычно купируются **за 48 часов**.

Постинтубационный отёк гортани: отёк начинается вскоре после интубации, а симптомы появляются после удаления трубки. Большинство пациентов предъявляют жалобы на лёгкие симптомы: боль в горле, дисфонию, затруднение глотания.

Появление стридора свидетельствует о клинически значимой обструкции верхних дыхательных путей; стридор и дыхательная недостаточность возникают при обструкции более половины просвета.

Клиническая картина может проявиться в первые минуты и часы после экстубации, однако описаны случаи отёка, потребовавшего реинтубации спустя **48–72 часа**. В среднем симптомы купируются **через 72 часа**, у большинства пациентов спонтанно **за 24–48 часов**.

Безопасного верхнего предела длительности интубации у детей нет.

Эпиглоттит: тяжёлая бактериальная инфекция.

1. острое начало с высокой температуры и нарушения общего состояния;
2. боль в горле, тризм, слюнотечение, поза «треножника», приоткрытый рот;
3. быстро нарастающий стридор, западение надгортанника в положении на спине;
4. типичного для крупа лающего кашля нет.

3. Диагностика

Критерии диагноза

1. круп: диагноз клинический, как правило устанавливается на основании анамнеза и симптомов — осиплости голоса, лающего кашля, инспираторного стридора;
2. эпиглоттит: острое начало с высокой температуры и нарушения общего состояния; боль в горле, тризм, слюнотечение, поза «треножника», приоткрытый рот; быстрое развитие стридора, западение надгортанника в положении на спине; лающего кашля нет;
3. постинтубационный отёк: боль в горле, дисфония, затруднение глотания, стридор после экстубации; инструментально — УЗИ гортани у интубированных, у взрослых также тест на герметичность манжеты.

Ротоглотку ребёнка с подозрением на эпиглоттит осматривают только в операционной в полной готовности к интубации: высок риск рефлекторного спазма гортани и асфиксии.

При крупе и эпиглоттите уточняют вакцинацию против гемофильной, пневмококковой инфекции и дифтерии.

3.1 Осмотр и аускультация

Признаки респираторного дистресса

1. цианоз;
2. участие вспомогательной мускулатуры;
3. втяжение яремной ямки и межрёберных промежутков;
4. частота дыхания;
5. сатурация.

Аускультативно уточняют характер одышки: при крупе она инспираторная, а экспираторной или смешанной становится при сопутствующей бронхиальной обструкции или тяжёлом крупе.

3.2 Пульсоксиметрия

Показания

1. круп и эпиглоттит: оценка дыхательной недостаточности, необходимости кислорода, динамики.

3.3 Общий анализ крови и С-реактивный белок

Показания

1. круп: только при высокой лихорадке, когда нужно исключить бактериальную инфекцию; в стационаре общий анализ крови всем, СРБ по необходимости.

Показания

1. подозрение на эпиглоттит, высокая лихорадка: развёрнутый общий анализ крови, при необходимости СРБ.

Для эпиглоттита характерны лейкоцитоз **более 15×10^9/л** и повышенный СРБ. Анализы берут, только когда это безопасно, иногда лишь после интубации.

3.4 Посев с надгортанника и посев крови

Показания

1. эпиглоттит, селективно: этиологическая диагностика с определением чувствительности.

Берут после восстановления проходимости дыхательных путей; посев с надгортанника у неинтубированного пациента противопоказан.

3.5 Рентгенография мягких тканей шеи

При крупе рутинно не проводят: неспецифична и малоинформативна.

Показания

1. сомнительные случаи эпиглоттита со стёртой симптоматикой: боковая проекция.

Диагностические признаки

1. отёк надгортанника — симптом «большого пальца».

Любое исследование при подозрении на эпиглоттит может спровоцировать обструкцию дыхательных путей.

3.6 УЗИ гортани и фиброларингоскопия перед экстубацией

Показания

1. интубированные взрослые и дети, селективно: проходимость верхних дыхательных путей перед экстубацией.

Измеряют ширину воздушного столба на уровне складок до и после сдувания манжеты; её уменьшение предсказывает постэкстубационный стридор, точность метода окончательно не установлена.

Фиброларингоскопия перед экстубацией при наличии ресурсов — пациентам с факторами риска, прежде всего после трудной интубации или со стридором и дисфонией через 48–72 часа. Подсвязочное пространство не видно, а стенозы обычно подсвязочные.

Показания

1. взрослые перед экстубацией: тест на герметичность манжеты (утечка воздуха при сдутой манжете).

У детей прогностическая ценность низкая, широко не применяется.

3.7 Дифференциальная диагностика

Круп и эпиглоттит дифференцируют между собой и с другими причинами обструкции верхних дыхательных путей. Эпиглоттиту не свойственны катаральные явления, кашель и осиплость. Уточняют атопию, эпизоды бронхообструкции или стеноза, признаки гастроэзофагеального рефлюкса.

Круп и эпиглоттит: клинические различия

Признак	Круп	Эпиглоттит
Возраст	6 месяцев – 3 года	старше 3 лет
Развитие стридора	постепенное (24–72 ч)	быстрое (8–12 ч)
Симптомы	катаральный продром, грубый лающий кашель, осиплость, грубый инспираторный стридор, редко шум на выдохе; боли в горле нет или умеренная	умеренный ринит, несильный кашель, приглушённый, но не осиплый голос, умеренный стридор, усиливается лёжа на спине, низкий звук на выдохе; боль в горле; «опасные» признаки: гиперсаливация, тризм
Лихорадка и интоксикация	чаще субфебрилитет, интоксикации нет	температура выше 39 °C, выраженная интоксикация и недомогание
Рентгенография	сужение дыхательных путей	отёк надгортанника, симптом «большого пальца»

Дифференциальная диагностика крупа с клинически сходными состояниями

Заболевание	Наиболее частый возраст	Клинические проявления	Лабораторная и инструментальная диагностика
Круп	6 месяцев – 6 лет	острое начало, «лающий» кашель, стридор, осиплость голоса	не требуется
Паратонзиллярный абсцесс	6 месяцев – 3,5 года	боль в горле, лихорадка, гнусавый голос, речь по типу «картошка во рту»; смещение миндалины вниз и медиально, отклонение нёбного язычка, гиперемия и (или) налёт на миндалинах, возможен тризм	рентгенография мягких тканей шеи, КТ шеи, клинический анализ крови (лейкоцитоз)
Заглоточный (ретрофарингеальный) абсцесс	2–4 года	лихорадка, слюнотечение, дисфагия, боль при глотании, боль в шее; возможны тризм, отёк шеи, вынужденное положение: голова запрокинута назад и повёрнута в сторону абсцесса	рентгенография мягких тканей шеи, КТ шеи с внутривенным болюсным контрастированием, клинический анализ крови (лейкоцитоз)
Ангиоотёк	в любом возрасте	отёк шеи и, возможно, лица, другие признаки аллергической (в том числе анафилактической) реакции; возникает после контакта с аллергеном или токсическим веществом	в дальнейшем аллергологическое обследование: кожные тесты или специфические иммуноглобулины E
Аспирация инородного тела	чаще до 3 лет	эпизод «поперхивания», острое затруднение дыхания, слюнотечение	рентгенография мягких тканей шеи, КТ шеи, трахеобронхоскопия
Химический и термический ожог верхних дыхательных путей	в любом возрасте	контакт с химическими веществами, тепловое воздействие	прямая ларингоскопия
Эпиглоттит	3–12 лет	острое нарушение глотания, боль при глотании, слюнотечение, высокая лихорадка, беспокойство, приглушённый голос	рентгенография мягких тканей шеи (утолщённый надгортанный хрящ), клинический анализ крови (лейкоцитоз)
Дифтерийный (истинный) круп	в любом возрасте	развивается медленнее, на фоне субфебрильной температуры (кроме токсической формы) и интоксикации; боль в шее и её отёк; налёты на миндалинах грязно-серого цвета, трудно отделяющиеся	посев на Corynebacterium diphtheriae, молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки на возбудителя дифтерии, определение антител к дифтерийному токсину
Бактериальный трахеит	до 6 лет	высокая лихорадка, «лающий» кашель, нарастающие симптомы дыхательной недостаточности	клинический анализ крови (лейкоцитоз), рентгенография мягких тканей шеи (сужение просвета трахеи)

Заболевание	Наиболее частый возраст	Клинические проявления	Лабораторная и инструментальная диагностика
Гемангиома	до 6 месяцев	усиление стридора на фоне беспокойства	трахеобронхоскопия
Аномалии верхних дыхательных путей: трахеомаляция, ларингомаляция, расщелина гортани, стеноз подсвязочного пространства	с первых 6 месяцев жизни до 4,5 года	рецидивирующие эпизоды «лающего» кашля и стридора	трахеобронхоскопия
Новообразования	в любом возрасте	нарастающие изменения дыхания и голоса	рентгенография мягких тканей шеи в боковой проекции, КТ шеи
Увулит	в любом возрасте	отёк и эритема нёбного язычка; этиология бактериальная или аллергическая; может сопутствовать эпиглоттиту	при аллергической этиологии — в дальнейшем аллергологическое обследование

При некоторых болезнях гортани (врождённый стридор, подскладочная гемангиома или неоплазия, парезы, ларингомаляция) затруднение вдоха усиливается во время острой респираторной инфекции и имитирует острый стеноз.

Постэкстубационный стридор дифференцируют с

1. ларингоспазмом;
2. ангионевротическим отёком, анафилаксией;
3. инородным телом дыхательных путей;
4. послеоперационной гематомой со сдавлением дыхательных путей;
5. парезом голосовых складок после операций на шее;
6. апноэ сна.

---

4. Лечение

4.1 Круп

Антибиотики при крупе не назначают: неэффективны.

Всем пациентам с крупом: ингаляционный будесонид и (или) системные кортикостероиды (#дексаметазон, #преднизолон).

Обычно достаточно однократного введения; детям **старше 3 лет** предпочтителен приём внутрь, он так же эффективен, как парентеральный. Повторное введение, как правило, не нужно.

1. #дексаметазон: 0,15–0,6 мг/кг внутримышечно или внутривенно при любой степени стеноза; внутрь предпочтительно 0,15 мг/кг;
2. нет дексаметазона: #преднизолон в эквивалентной дозе (1 или 2 мг/кг соответствуют 0,15 и 0,6 мг/кг дексаметазона); после преднизолона выше риск повторных симптомов.

1. будесонид, суспензия через компрессорный или мэш-небулайзер: 2 мг в сутки однократно или по 1 мг дважды с интервалом 30 минут;
2. в 85% случаев (обычно при стенозе I степени) достаточно одной ингаляции; при необходимости ингаляции повторяют согласно инструкции.

Системные кортикостероиды, по ряду данных, эффективнее ингаляционных: беспокойство ребёнка мешает ингаляции.

Будесонид к #дексаметазону рутинно не добавляют: дополнительного эффекта нет.

Показания

1. тяжёлый круп или нет кортикостероидов: ингаляция #эпинефрина.

Доза

1. раствор 1:1000, 5 мл на ингаляцию независимо от возраста и массы.

Эффект быстрый, но нестойкий (**не более 2 часов**): в монотерапии не применяют. У детей препарат применяют вне инструкции, по решению врачебной комиссии с информированным согласием.

Исследований о необходимости и эффективности повторных ингаляций #эпинефрина не проводилось. Есть данные об эффективности более низких доз (ниже 0,5 мг/кг).

Показания

1. круп гриппозной этиологии: ингибиторы нейраминидазы — осельтамивир **с 1 года**, занамивир **с 5 лет**.

Других этиотропных средств против вирусов крупа нет.

Паровые ингаляции не рекомендуются: эффективность низкая.

При сатурации **92% и ниже** показана оксигенотерапия.

При стенозе гортани IV степени необходима неотложная интубация трахеи, при III степени её целесообразность рассматривают.

Жаропонижающая терапия

1. у детей допустимы только парацетамол или ибупрофен;
2. здоровым детям **от 3 месяцев**: при температуре **выше 39–39,5 °C**;
3. при лихорадке **38–38,5 °C**: детям **до 3 месяцев**, пациентам с хронической патологией, а также при дискомфорте, связанном с температурой.

Регулярный (курсовой) приём жаропонижающих нежелателен: повторную дозу вводят только после нового повышения температуры. Чередование парацетамола и ибупрофена или их комбинация не усиливает эффект. Ацетилсалициловую кислоту и нимесулид у детей с жаропонижающей целью не применяют; метамизол натрия крайне нежелателен из-за риска агранулоцитоза.

4.2 Эпиглоттит

Пациента не укладывают: только сидя, в том числе при транспортировке.

Ранняя интубация трахеи для профилактики внезапной асфиксии. Экстубация безопасна после нормализации температуры, прояснения сознания и стихания симптомов, обычно **через 24–48 часов**. В редких нетяжёлых случаях интубация может не понадобиться.

Ингаляции, снотворные и седативные средства категорически не рекомендуются; беспокойство пациента не провоцируют, поскольку высок риск рефлекторного ларингоспазма.

Всем пациентам с эпиглоттитом: системный антибиотик внутривенно.

Препараты и дозы

1. цефотаксим по инструкции или цефтриаксон: дети **от 15 дней до 12 лет** 20–80 мг/кг в сутки, оптимально 75 мг/кг в сутки; масса **более 50 кг и старше 12 лет** — дозы для взрослых;
2. в монотерапии или с антистафилококковым препаратом, например #ванкомицином 40 мг/кг в сутки;
3. неэффективность (вероятен S. aureus): клиндамицин 30 мг/кг в сутки внутривенно (по инструкции **с 3 лет**) или ванкомицин 40 мг/кг в сутки;
4. взрослые: те же препараты по инструкции, ванкомицин в средней дозе 40 мг/кг в сутки.

Длительность **7–10 дней**: сначала внутривенно, после купирования лихорадки, нормализации состояния и восстановления приёма жидкости через рот — внутрь: амоксициллин + клавулановая кислота, цефуроксим и другие цефалоспорины II–III поколения. Макролиды при эпиглоттите не применяют.

Эпиглоттит часто сопровождается бактериемией, что увеличивает длительность лечения. По зарубежным публикациям, доза цефтриаксона при эпиглоттите у детей составляет 50–100 мг/кг в сутки.

Сатурация **ниже 92%**: оксигенотерапия.

4.3 Постэкстубационный отёк гортани

Показания

1. симптомы постэкстубационного отёка у взрослых и детей: системные глюкокортикоиды внутривенно.

Дозы

1. дексаметазон: взрослым 5 мг на введение; детям в среднем 0,6 мг/кг в сутки;
2. метилпреднизолон: взрослым 20–40 мг;
3. #преднизолон: детям в среднем 1 мг/кг в сутки (от менее 1 до 2 мг/кг в сутки);
4. длительность **не менее 48 часов**.

Дополнительно, селективно

1. #эпинефрин ингаляционно: взрослым 1000 мкг в 5 мл 0,9% натрия хлорида; детям 1% раствор 0,25 мл в 2 мл 0,9% натрия хлорида или 0,5 мл, 2,5 мл, максимально 5 мл;
2. #будесонид небулайзером: взрослым и детям 1000 мкг 2 раза в сутки.

Возможны и более низкие дозы эпинефрина: после экстубации причина отёка устранена.

При отсутствии улучшения **в течение часа** консервативной терапии выполняют реинтубацию, не прерывая лечения.

Профилактика постэкстубационного отёка

Системные глюкокортикоиды с профилактической целью вводят селективно, пациентам с риском постэкстубационного отёка (факторы риска перечислены ниже), у взрослых — например, при отрицательном тесте на утечку воздуха из манжеты. Взрослым их вводят **не менее чем за 4 часа** до экстубации (по данным других авторов, **за 6–12 часов**).

Режим дозирования

1. взрослые: #метилпреднизолон 40 мг внутривенно **за 24 ч** до экстубации, или 40 мг 4 раза **за 24 ч**, или 20 мг 3 раза **за 12 ч**, или 40 мг **за 4 ч**; либо #дексаметазон 8 мг внутривенно **за 1 ч** или 5 мг 4 раза **за 48 ч** до экстубации;
2. дети: #дексаметазон 0,5 мг/кг на дозу каждые 6 часов **в течение 24 ч** до экстубации;
3. недоношенные новорождённые: 0,25 мг/кг, 4 дозы с интервалом 6 часов.

Наиболее эффективно введение **за 12–24 часа** до экстубации, далее при показаниях **24–48 часов** после неё; у детей раннее введение (**за 6–12 часов**) важнее дозы.

Выбор стратегии применения #дексаметазона учитывает

1. риск постэкстубационного отёка гортани;
2. факторы риска неудачи экстубации, в том числе слабость дыхательных мышц;
3. возможные побочные эффекты, в том числе желудочно-кишечное кровотечение и артериальную гипертензию;
4. время до плановой экстубации.

Факторы риска постинтубационного отёка гортани

Связанные с интубацией

1. трудная интубация в анамнезе;
2. большой размер трубки;
3. подвижность трубки;
4. интубация у детей **более недели**;
5. ИВЛ **48 часов** у детей **до 12 месяцев**;
6. экстренная интубация вне стационара.

После интубации

1. длительная интубация;
2. высокое давление в манжете;
3. возбуждение пациента;
4. самоэкстубация и реинтубация;
5. агрессивная аспирация слизи из трахеи.

Пациент и операция

1. операции на голове и шее, положение лёжа на животе при нейрохирургических операциях;
2. беременность, инфузионная терапия;
3. повреждения шеи и дыхательных путей, ингаляционные повреждения и ожоги;
4. низкий балл по шкале Глазго, лечение без седации;
5. женский пол, индекс массы тела более 26,5, гастроэзофагеальный рефлюкс, узкая гортань;
6. малый гестационный возраст, низкая масса тела при рождении, детский возраст.

4.4 Стеноз гортани вследствие отёка и хирургическое лечение

При стенозе гортани у пациентов любого возраста проводят консервативную дестенозирующую терапию: парентерально вводят глюкокортикоиды и петлевые диуретики.

При асфиксии и невозможности интубации у ребёнка с крупом и у пациента с эпиглоттитом выполняют трахеотомию с временной трахеостомой или коникотомию. В неосложнённых случаях хирургическое лечение не требуется.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Круп: дети с суммой баллов по шкале Westley **1–2**, как правило, не нуждаются в госпитализации; эффект ингаляции будесонида или инъекции #дексаметазона дома или амбулаторно позволяет обойтись без неё.

Показания к госпитализации

1. стеноз гортани II–III степени;
2. невозможность адекватной терапии дома;
3. прогрессирующее ухудшение состояния.

Госпитализация проводится в инфекционный стационар или боксированное отделение. Стационарную помощь оказывает врач-педиатр или врач-инфекционист, при необходимости — врач-оториноларинголог, по показаниям — врач-анестезиолог-реаниматолог. Выписка после купирования стеноза, нормализации температуры и сатурации; в среднем **1–2 дня**.

Родителей детей с рецидивирующим крупом обучают и составляют план действий: при симптомах нового эпизода — ингаляция будесонида или #дексаметазон (#преднизолон) внутримышечно.

Эпиглоттит: обязательная экстренная госпитализация, обычно бригадой скорой помощи, в отделение с интенсивной терапией и возможностью интубации.

Любые болезненные или неприятные пациенту манипуляции — инъекции, инфузии, иногда даже ингаляции — могут вызвать асфиксию. В стационаре в среднем **3–5 дней**. Стационарную помощь оказывает врач-педиатр (врач-терапевт) или врач-инфекционист, при необходимости — врач-оториноларинголог, по показаниям — врач-анестезиолог-реаниматолог.

Выписка

1. купирование стеноза;
2. нормальная температура и сатурация;
3. самостоятельный приём пищи и жидкости, аппетит.

5.2 Профилактика

Круп

1. гигиена: мытьё рук после контакта с больным, маски, обработка поверхностей и инструментов, изоляция заболевших детей, проветривание;
2. вакцинация от сезонного гриппа всем детям без противопоказаний.

Исследований о снижении частоты крупа у вакцинированных от гриппа детей нет. Поскольку круп может развиваться на фоне гриппа, от вакцинации ожидают положительного эффекта в профилактике крупа, вызванного вирусами гриппа.

Эпиглоттит: вакцинация против гемофильной инфекции всем детям без противопоказаний. Диспансерное наблюдение при крупе и эпиглоттите не требуется; медицинская реабилитация не требуется.

Исход крупа при своевременной диагностике и адекватном лечении благоприятный; при поздней диагностике со стенозом III–IV степени и невозможности интубации или трахеостомии возможна смерть от асфиксии. Прогноз эпиглоттита всегда серьёзный, своевременное лечение обеспечивает выздоровление.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Острый обструктивный ларингит [круп], эпиглоттит, постинтубационный отёк гортани»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 14.01.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее января 2028 года
Код в рубрикаторе	352_3 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Союз педиатров России; МАКМАХ; Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Существенных неточностей и противоречий, влияющих на диагностику и лечение, не найдено.